Szpital Powiatowy w Zielonej Dąbrowie
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym
ul. Źródlana 9, 66-412 Zielona Dąbrowa · tel. 95 000 21 40

Karta informacyjna leczenia szpitalnego

Pacjent	Zbigniew Wróblewski	**Data urodzenia**	14.03.1957
Adres	ul. Jaśminowa 3, Stara Łąka	**Nr księgi głównej**	2026/04412
Przyjęty	28.09.2026, godz. 22:40	**Wypisany**	06.10.2026
Tryb przyjęcia	nagły, przez SOR	**Lekarz prowadzący**	lek. Ewa Słowińska

Rozpoznanie

Kod ICD-10	Rozpoznanie
I50.1	Niewydolność lewokomorowa serca, zaostrzenie
I48.1	Migotanie przedsionków przetrwałe
E11.6	Cukrzyca typu 2 z innymi określonymi powikłaniami
N18.3	Przewlekła choroba nerek, stadium 3

Wywiad

Pacjent przyjęty z powodu narastającej od tygodnia duszności wysiłkowej, obrzęków kończyn dolnych i przyrostu masy ciała o około 4 kg. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze od 2009 roku, cukrzyca typu 2 leczona metforminą oraz przebyty zawał serca w 2018 roku. Nie pali tytoniu od dwunastu lat.

Przebieg hospitalizacji

Przy przyjęciu stwierdzono cechy zastoju w krążeniu płucnym, saturację 89% bez tlenoterapii oraz szybką akcję serca w przebiegu migotania przedsionków. Zastosowano diuretyk pętlowy dożylnie, tlenoterapię bierną i kontrolę częstości rytmu, uzyskując stopniową poprawę stanu ogólnego.

W badaniu echokardiograficznym frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła 35%, bez istotnych wad zastawkowych. W trakcie pobytu ujemny bilans płynów wyniósł łącznie 6,2 litra, a masa ciała zmniejszyła się o 5 kg.

Pacjent został wypisany do domu w stanie ogólnym dobrym, wydolny krążeniowo w spoczynku.

Wyniki badań laboratoryjnych

Badanie	Wynik		Jednostka	Zakres referencyjny
	29.09.2026	05.10.2026		
NT-proBNP	6840	2115	pg/ml	< 125
Kreatynina	1,62	1,48	mg/dl	0,70 – 1,20
eGFR	43	48	ml/min/1,73 m²	> 60
Potas	3,6	4,4	mmol/l	3,5 – 5,1
Sód	134	137	mmol/l	136 – 145
Hemoglobina glikowana HbA1c	7,9	—	%	< 6,5
Troponina T hs	24	19	ng/l	< 14
Hemoglobina	12,8	12,5	g/dl	13,5 – 17,5

Zalecenia

1. Dieta z ograniczeniem soli kuchennej do 5 g na dobę i płynów do 1,5 litra na dobę.
2. Codzienna kontrola masy ciała; przyrost o więcej niż 2 kg w ciągu trzech dni wymaga kontaktu z lekarzem.
3. Kontrola stężenia potasu i kreatyniny za 7 dni w poradni rodzinnej.
4. Wizyta w Poradni Kardiologicznej za 4 tygodnie, skierowanie wydano.
5. Unikanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Leki zalecane po wypisie

Lek	Dawka	Sposób stosowania	Uwagi
Torasemid	10 mg	1 tabletka rano	na czczo
Bisoprolol	5 mg	1 tabletka rano	—
Sakubitryl z walsartanem	49/51 mg	1 tabletka dwa razy dziennie	kontrola ciśnienia
Apiksaban	5 mg	1 tabletka dwa razy dziennie	bez przerw
Empagliflozyna	10 mg	1 tabletka rano	—
Metformina	500 mg	1 tabletka wieczorem	po posiłku

Pacjent otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 20 października 2026 roku. Wyniki badań dołączono do karty.

Kierownik Oddziału

Lekarz prowadzący